Demam turun belum tentu aman. Pada DBD, justru saat itu keluarga harus lebih awas.

Lihat hari sakit, nyeri perut, muntah, perdarahan, tenaga, dan kencing. Jangan terpaku pada angka panas atau trombosit saja.

Hari 3-5 rawan | **Minum dan kencing** | **Jangan tunda periksa**

Ringkas 1 kalimat: pada DBD, demam turun belum tentu aman; segera cari bantuan bila muncul nyeri perut, muntah terus, perdarahan, sesak, sangat lemas, atau kencing makin sedikit, terutama pada 24-48 jam setelah panas reda.

1) Kenali DBD dulu

Konteks: DBD adalah infeksi virus dengue yang ditularkan nyamuk Aedes. Langkah praktis: kenali gejala awal dan selalu catat hari sakit. Kapan evaluasi medis: periksa bila demam tinggi disertai nyeri badan hebat, muntah, ruam, atau pasien tinggal di area dengan risiko dengue.

WHO menjelaskan bahwa banyak infeksi dengue ringan atau tanpa gejala, tetapi pada orang yang sakit, keluhan yang paling sering adalah demam tinggi, sakit kepala, nyeri belakang mata, nyeri otot dan sendi, mual, muntah, dan ruam. CDC juga menekankan bahwa gejala umumnya berlangsung 2-7 hari, sehingga catatan hari sakit membantu keluarga melihat kapan masuk fase yang lebih berisiko.

Gejala awal yang sering

- Demam tinggi mendadak.
- Sakit kepala atau nyeri belakang mata.
- Ngilu badan, pegal, lemas.
- Mual, muntah, atau ruam.

Yang sering bikin telat sadar

- Demam turun dianggap sudah sembuh.
- Keluarga hanya menunggu angka trombosit.
- Minum berkurang tetapi belum dianggap masalah.

Catatan penting: pemeriksaan darah memang membantu konfirmasi, tetapi keputusan untuk periksa atau dirujuk tidak harus menunggu hasil laboratorium bila kondisi klinis sudah mengkhawatirkan.

Pegangan keluarga di rumah

- Tulis hari ke-1 saat demam mulai jelas, bukan saat ruam muncul.
- Catat apakah pasien masih bisa minum, masih pipis, dan apakah ada muntah atau perdarahan.
- Kalau pasien pernah kena dengue sebelumnya, risiko dengue berat bisa lebih tinggi, jadi jangan terlalu santai.

Jangan terkunci pada satu gejala. DBD bisa mirip infeksi virus lain pada awalnya. Karena itu, kombinasi gejala dan fase hari sakit lebih berguna daripada hanya melihat panas badan.

2) Fase hari 1-7: bagian paling penting

Konteks: CDC Yellow Book membagi dengue menjadi fase demam, kritis, dan pemulihan. Langkah praktis: cocokkan kondisi pasien dengan fase hari sakit. Kapan evaluasi medis: jangan tunggu bila masuk fase kritis dan mulai muncul warning signs.

Hari 1-3

Fase demam

Biasanya demam tinggi, pegal, sakit kepala, mual, atau ruam mulai tampak.

- Fokus pada cairan, istirahat, dan pemantauan.
- Catat muntah, asupan minum, dan kencing.
- Bila sudah ada sesak atau perdarahan, jangan tunggu.

Hari 3-5

Fase kritis

Ini fase yang paling sering mengecoh. Demam bisa turun, tetapi risiko kebocoran plasma, syok, dan perdarahan justru naik.

- Waspada kuat pada 24-48 jam setelah panas reda.
- Nilai nyeri perut, muntah, perdarahan, rewel, lemas, dan kencing.
- Bila ada tanda bahaya, periksa segera.

Hari 5-7

Fase pemulihan

Bila kondisi stabil, nafsu makan dan tenaga pelan-pelan kembali, dan kencing membaik.

- Tetap lanjut minum dan istirahat.
- Ikuti kontrol bila dokter minta pemantauan ulang.

Pesan inti: menurut CDC, warning signs biasanya mulai pada 24-48 jam setelah demam hilang. Jadi kalimat "panasnya sudah turun" bukan alasan untuk berhenti memantau.

Apa yang dipantau per fase

Hari 1-3
Demam, pegal, mual, ruam.

Hari 3-5 — Zona paling rawan terlewat
Saat panas turun:
cek perut, muntah, darah, kencing.

Hari 5-7
Bila stabil, makan dan tenaga mem

3) Kapan harus ke dokter atau IGD

Konteks: ini bagian terpenting untuk keselamatan pasien. Langkah praktis: bedakan mana yang perlu dinilai hari itu juga dan mana yang tidak boleh ditunda. Kapan evaluasi medis: segera bila salah satu tanda ini muncul, terutama saat demam mulai turun.

Segera ke IGD atau layanan darurat bila pasien sangat lemas atau sulit dibangunkan, sesak atau napas cepat, perdarahan nyata, muntah darah, BAB hitam atau berdarah, tangan-kaki dingin pucat, bingung, atau tampak akan kolaps.

Periksa hari ini juga

- Nyeri perut yang nyata atau makin berat.
- Muntah berulang, apalagi 3 kali atau lebih dalam 24 jam.
- Mimisan, gusi berdarah, darah di urin atau tinja.
- Pasien tampak sangat lelah, gelisah, atau rewel tidak seperti biasa.
- Minum masuk sedikit, bibir kering, atau kencing mulai berkurang.

Kalau ragu masuk kategori mana, pilih jalur yang lebih aman: periksa lebih cepat.

Tanda yang mengarah ke kondisi berat

1. **Gangguan sirkulasi:** pucat, dingin, lemah sekali, tampak mau pingsan.
2. **Gangguan napas:** napas cepat, sesak, atau terasa berat.
3. **Perdarahan bermakna:** muntah darah, BAB hitam, mimisan tidak berhenti, atau darah banyak dari gusi.
4. **Kesadaran berubah:** mengantuk berat, bingung, gelisah, atau sulit dibangunkan.

CDC mencatat warning signs biasanya muncul setelah demam pergi. Jadi bila suhu turun lalu pasien malah memburuk, jangan menunggu besok.

4) Alur keputusan cepat untuk keluarga

Konteks: bagian ini membantu keluarga memutuskan langkah awal. Langkah praktis: cocokkan kondisi pasien dengan tiga jalur di bawah. Kapan evaluasi medis: bila bergeser dari hijau ke kuning atau merah, jangan bertahan di rumah.

Boleh observasi dan rawat rumah

- Masih kuat minum sedikit demi sedikit.
- Kencing masih ada dan tidak makin sedikit.
- Tidak ada nyeri perut berat, muntah terus, atau perdarahan.
- Kondisi umum masih relatif stabil.

Aksi: istirahat, cairan, parasetamol bila perlu, pantau ketat hari sakit dan warning signs.

Perlu kontak klinik hari ini

- Masuk hari 3-5 atau panas baru saja turun.
- Minum mulai berkurang, muntah mulai sering, atau perut mulai sakit.
- Ada komorbid, hamil, lansia, bayi, atau akses ke fasilitas kesehatan sulit.

Aksi: hubungi klinik untuk dinilai dan ditentukan apakah cukup rawat jalan atau perlu dirujuk.

IGD atau segera periksa

- Ada satu saja tanda bahaya.
- Pasien tidak kuat minum atau muntah terus.
- Tampak sangat lemah, sesak, pucat dingin, atau perdarahan.

Aksi: jangan tunda hanya untuk menunggu trombosit atau menunggu obat tambahan.

5) Rawat di rumah: apa yang aman dilakukan

Konteks: tidak semua pasien DBD harus langsung rawat inap, tetapi rawat rumah harus disiplin. Langkah praktis: utamakan cairan, istirahat, dan pemantauan. Kapan evaluasi medis: bila pasien tidak sanggup minum, muntah terus, atau kondisi umumnya turun.

WHO dan CDC sama-sama menekankan bahwa tidak ada obat khusus untuk membunuh virus dengue. Perawatan awal lebih banyak pada dukungan cairan, istirahat, pengendalian nyeri dan demam, serta deteksi dini tanda berat.

Cairan: sedikit tapi sering

- Air putih, oralit, kuah bening, atau minuman lain yang mudah diterima.
- Jangan tunggu haus sekali baru minum.
- Bila mual, beri sedikit-sedikit tetapi lebih sering.

Pantau yang sederhana

- Masih bisa minum atau tidak.
- Masih pipis atau makin sedikit.
- Ada muntah, darah, nyeri perut, atau sesak.
- Hari sakit sudah masuk fase rawan atau belum.

Makan dan istirahat

- Beri makan ringan bila sanggup.
- Jangan memaksa makan banyak sekaligus.
- Istirahat cukup, tidak perlu aktivitas berat.

Patokan praktis: kalau pasien tetap bisa minum, masih pipis, dan tidak ada tanda bahaya, rawat rumah masih mungkin aman. Begitu salah satu patokan itu mulai goyah, jangan bertahan terlalu lama di rumah.

Pantau 4 hal di rumah

1. Minum masih masuk? ✓
2. Kencing masih ada? ✓
3. Perut, muntah, darah, sesak? +
4. Ini hari sakit keberapa? ✗

6) Obat saat DBD: mana yang relatif aman, mana yang

Panduan keluarga ZMC

Demam berdarah: pahami fase hari 1-7 dan jangan terkecoh saat demam mulai turun

Aman sebagai pegangan awal	Yang perlu dihindari tanpa arahan dokter	Catatan untuk keluarga
Parasetamol untuk demam atau nyeri, sesuai dosis.	Aspirin, ibuprofen, dan NSAID lain karena bisa menaikkan risiko perdarahan.	Cek kandungan obat flu kombinasi agar tidak dobel parasetamol.
Kompres suam-suam kuku bila pasien tidak nyaman.	Antibiotik tanpa indikasi karena dengue adalah infeksi virus.	Antibiotik tidak dipakai hanya karena panas tinggi atau trombosit turun.
Oralit atau cairan lain bila asupan turun dan pasien masih bisa minum.	Obat atau suplemen yang dijual sebagai "penambah trombosit" tanpa evaluasi klinis.	Trombosit rendah bukan satu-satunya penentu berat-ringannya pasien.

Jangan mengejar angka saja. Menurut CDC dan WHO, keputusan perawatan terutama berdasar kondisi pasien, warning signs, hidrasi, dan fase penyakit, bukan sekadar satu hasil trombosit.

7) Kondisi khusus: siapa yang sebaiknya dievaluasi lebih cepat

Konteks: tidak semua pasien punya cadangan tubuh dan risiko yang sama. Langkah praktis: turunkan ambang untuk konsultasi pada kelompok rentan. Kapan evaluasi medis: lebih cepat dari standar bila pasien termasuk kelompok ini.

CDC case management menempatkan kehamilan, usia sangat muda atau lanjut, serta komorbid sebagai alasan untuk menilai pasien lebih serius. Di praktik keluarga, artinya jangan terlalu lama observasi sendiri, terutama pada bayi prematur atau pasien dengan riwayat reaksi obat berat.

Bayi dan anak kecil

Bayi kurang dari 1 tahun atau anak kecil lebih mudah jatuh ke dehidrasi karena cadangan cairannya terbatas dan sulit menjelaskan keluhan.

Bayi prematur atau gizi kurang

Bayi dengan riwayat prematur atau status gizi kurang lebih mudah turun kondisi umumnya. Bila demam dan minum turun, evaluasi langsung jangan ditunda.

Ibu hamil

Kehamilan perlu dinilai lebih cepat. Bila demam tinggi, muntah, lemas, atau masuk fase kritis, jangan menunda pemeriksaan.

Lansia

Pada usia lanjut, tanda syok bisa lebih samar, sementara penyakit penyerta lebih sering ada.

Pasien komorbid

Hipertensi, diabetes, asma, ginjal kronis, penyakit hati, obesitas, atau penggunaan antikoagulan membuat evaluasi medis perlu lebih dini.

Riwayat alergi obat berat

Bila pernah sesak, bengkak, atau pingsan setelah obat tertentu, jangan coba obat baru tanpa arahan dokter. Bawa informasi alergi saat kontrol atau ke IGD.

Apa yang dibawa saat kontrol

- Hari sakit dan kapan demam mulai turun.
- Catatan muntah, kencing, perdarahan, dan asupan minum.
- Daftar obat yang sudah diminum.
- Riwayat prematur, alergi obat berat, atau reaksi obat sebelumnya.
- Riwayat kehamilan atau penyakit penyerta bila ada.

8) Pencegahan: PSN 3M Plus yang relevan untuk rumah tangga

Konteks: nyamuk Aedes berkembang biak di tempat penampungan air bersih. Langkah praktis: lakukan 3M Plus rutin, bukan hanya saat ada warga yang sakit. Kapan evaluasi medis: bila ada demam yang cocok dengan dengue, tetap periksa walau rumah terasa sudah bersih.

Ayo Sehat Kemenkes menekankan bahwa pencegahan DBD yang paling efektif tetap PSN 3M Plus. Untuk rumah tangga Garut, artinya bukan hanya bak mandi, tetapi juga ember cadangan, talang yang mampet, dispenser galon, vas, tatakan pot, dan tempat minum hewan.

Menguras

Bersihkan bak mandi, toren kecil, ember, tempat air wudhu, atau wadah lain secara rutin. Gosok dinding wadahnya juga.

Menutup

Tutup rapat penampungan air supaya nyamuk tidak punya tempat bertelur.

Mendaur ulang

Singkirkan kaleng, botol, ban, gelas plastik, dan barang bekas yang bisa menampung air hujan.

Bagian "Plus" meliputi memperbaiki talang mampet, memeriksa jentik, memakai repelan, memasang kasa, menaruh pakaian kotor di wadah tertutup, dan memakai larvasida pada tempat air yang sulit dibersihkan.

Checklist 3M Plus rumah

- ✔ Bak mandi dan ember dikuras
- ✔ Toren, gentong, dispenser ditutup
- ✔ Talang, tatakan pot, vas dicek
- ✔ Baju bekas pakai tidak digantung lama
- ✔ Larvasida untuk wadah sulit dibersihkan
- ✔ Repelan dan kasa dipakai saat perlu

9) Mitos vs fakta yang sering bikin salah langkah

Konteks: pada DBD, miskonsepsi kecil bisa bikin keluarga datang terlambat. Langkah praktis: pakai fakta berikut sebagai rem pengingat. Kapan evaluasi medis: kalau fakta di bawah justru cocok dengan kondisi pasien, ambil tindakan lebih cepat.

Mitos: kalau demam sudah turun berarti sudah lewat.

Fakta: justru fase kritis sering muncul saat demam turun. Nilai kondisi umum, nyeri perut, muntah, perdarahan, dan kencing pada 24-48 jam setelahnya.

Mitos: rawat inap ditentukan hanya oleh trombosit.

Fakta: kondisi klinis, warning signs, hidrasi, tekanan darah, dan fase sakit lebih menentukan keputusan cepat daripada satu angka laboratorium.

Mitos: semua ruam atau bintik merah berarti pasti DBD.

Fakta: ruam bisa ada pada dengue, tetapi tidak wajib ada. Banyak pasien datang hanya dengan demam, pegal, mual, atau lemas.

Mitos: antibiotik atau obat penambah trombosit harus segera diminum.

Fakta: dengue disebabkan virus. Obat utama di rumah adalah cairan, istirahat, pemantauan, dan obat nyeri yang tepat, bukan mengejar obat tambahan tanpa evaluasi.

10) FAQ singkat

Konteks: ini jawaban untuk pertanyaan rumah tangga yang paling sering muncul. Langkah praktis: pakai sebagai panduan awal. Kapan evaluasi medis: kalau kondisi nyata pasien lebih berat dari pola umum ini, utamakan periksa langsung.

DBD menular langsung dari orang ke orang? +

Kalau trombosit belum turun, apakah aman? -

Belum tentu. Warning signs dan keadaan umum pasien lebih penting daripada satu angka. Pada fase kritis, pasien bisa tampak memburuk walau keluarga belum melihat hasil laboratorium terbaru.

Boleh ibuprofen untuk pegal atau sakit kepala? +

Kapan pasien tidak layak rawat rumah lagi? +

Kalau rumah sudah rajin 3M Plus, masih mungkin kena DBD? +

11) Rujukan

Konteks: halaman ini disusun dari sumber resmi yang relevan untuk pasien. Langkah praktis: buka saat online bila ingin baca lebih detail. Kapan evaluasi medis: bila kondisi pasien mengkhawatirkan, jangan berhenti di bagian rujukan - langsung periksa.

1. WHO. Dengue and severe dengue. Pembaruan 21 Agustus 2025. Dasar gejala umum, warning signs, larangan ibuprofen/aspirin, dan pesan bahwa tidak ada terapi antivirus spesifik.
2. CDC. Symptoms of Dengue and Testing. Pembaruan 7 Agustus 2025. Dasar gejala paling umum, warning signs, dan fase 24-48 jam setelah demam turun.
3. CDC Yellow Book. Dengue. Konten diperbarui 23 April 2025 (halaman ditinjau 19 September 2025). Dasar pembagian fase demam, kritis, dan pemulihan.
4. CDC. Dengue Case Management Pocket Guide. Dasar warning signs rinci, alasan rujukan/rawat inap, dan kelompok risiko termasuk hamil, bayi, lansia, dan komorbid.
5. Kemenkes RI - Ayo Sehat. Cara Mencegah DBD dengan Menjaga Lingkungan dan Diri Sendiri. Publikasi 4 Juli 2024. Dasar praktik PSN 3M Plus untuk rumah tangga Indonesia.
6. Kemenkes RI - Pusat Krisis. Percepat Penurunan Kasus DBD dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik. Dasar penguatan PSN dan pemantauan jentik berbasis keluarga/lingkungan.

> Konten ini adalah edukasi pasien. Untuk keputusan tes, rawat inap, infus, kehamilan, bayi, atau penyakit penyerta, tetap perlu pemeriksaan langsung oleh tenaga kesehatan.

Aksi cepat keluarga

Simpan halaman ini bila ingin dipakai saat offline. Bila ada tanda bahaya, masuk hari 3-5, atau keluarga merasa kondisi pasien "beda dari biasanya", hubungi fasilitas kesehatan tanpa menunggu lebih lama.

Zihan Medical Center

#ZMCGakNyuekinKamu - layanan 24 jam untuk keluarga Wanaraja dan sekitarnya.

Jl. Kudang, Wanajaya, Wanaraja, Wanajaya, Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44183

Telepon: +62 822-1718-0432

Jam: Senin - Minggu: 24 Jam

Kontak dan lokasi

WhatsApp **Maps**

Instagram

Tip offline: simpan file ini satu folder dengan `zmc-logo.jpeg` agar logo tetap tampil saat dibuka langsung dari perangkat.

© 2026 Zihan Medical Center - Wanaraja Garut

Materi edukasi pasien. Bukan pengganti pemeriksaan langsung.